PACIENTUL SPUNE DA™ · MATERIAL PRINCIPAL

Texte de informare a pacientului pentru 40 de tipuri de caz

Texte de conversație gata de folosit pentru 40 de tipuri de caz, ca după examinare să prezinți planul pacientului sau părintelui simplu, sincer și fără presiune.

Manualul Ortodontului

Cuprins

1 · Ghid de utilizare și principiile informării etice

2 · Clasa I și probleme de spațiu (cazurile 01–08)

3 · Cazuri de Clasa a II-a (cazurile 09–16)

4 · Cazuri de Clasa a III-a (cazurile 17–21)

5 · Probleme verticale și transversale (cazurile 22–28)

6 · Numărul și poziția dinților (cazurile 29–34)

7 · Adulți și situații speciale (cazurile 35–40)

8 · Listă de verificare după informare

CAPITOLUL 1

Ghid de utilizare

Fiecare caz ocupă o pagină: mai întâi uită-te la cadru, apoi spune textul cu propriile cuvinte.

> *Aceste texte nu sunt scenarii de învățat pe de rost. Sunt un schelet pe care, după ce ai consultat documentația pacientului, îl poți umple cu cuvintele care ți se potrivesc.*

1. **Găsește tipul de caz.** Din cuprins sau din tabelul de la începutul capitolului alege tipul de caz cel mai apropiat. Dacă există mai multe probleme, folosește mai întâi pe cea mai apropiată de plângerea pacientului.
2. **Citește cadrul clinic.** Informația din casetă este pentru tine, nu o citești pacientului. Taie din text propoziția care nu corespunde constatărilor tale.
3. **Spune textul pe înțelesul tuturor.** Dacă trebuie să folosești un termen de specialitate, explică-l imediat după aceea în cuvinte de zi cu zi.
4. **Explică aparatul sau extracția separat.** Această informație vine după textul principal și numai după ce ai lăsat timp pentru întrebările pacientului.
5. **Fii atent la expresiile de evitat.** Propozițiile din coloana din dreapta transmit aceeași informație, fără presiune și fără promisiuni.
6. **Verifică dacă s-a înțeles.** Întreabă: „Ați putea rezuma cu propriile cuvinte ce v-am spus?" Nu aștepta o decizie în aceeași zi.

CELE 6 PRINCIPII ALE INFORMĂRII ETICE	ÎN PRACTICĂ
1 · Ascultă mai întâi	Notează plângerea și așteptările pacientului sau ale părintelui cu cuvintele lor; de acolo pornești cu planul.
2 · Descrie ce vezi, nu judeca	În loc de „strâmb", „stricat", „rău", folosește cuvinte descriptive: „stă mai în față", „este înghesuit", „se închide invers".
3 · Prezintă opțiunile	Toate opțiunile adecvate, inclusiv renunțarea la tratament și monitorizarea. Recomandarea ta și motivul ei le spui separat.
4 · Nu promite	Pentru durată, un interval aproximativ; pentru rezultat, un obiectiv. Fără „sigur", „garantat", „perfect".

CELE 6 PRINCIPII ALE INFORMĂRII ETICE	ÎN PRACTICĂ
5 · Spune clar sarcina pacientului	Igiena orală, purtarea elasticelor sau a aparatului, respectarea controalelor și contenția.
6 · Oferă timp pentru decizie	Nu aștepta o decizie în aceeași zi. Lasă-l să ia acasă planul scris și declarația de consimțământ folosită de cabinetul tău.

Scheletul în 5 părți al fiecărei informări

PARTEA	ÎNTREBAREA	EXEMPLU DE PROPOZIȚIE DE ÎNCEPUT
1 · Ce văd	Ce am găsit?	„La examinare și pe imagini vedem următoarele…"
2 · De ce contează	Ce se poate întâmpla fără tratament?	„Cu timpul, aceasta poate duce la…"
3 · Ce recomand	Obiectivul și metoda	„Obiectivul nostru este… Pentru aceasta, calea pe care o recomand este…"
4 · Posibilități	Alte căi și limitările lor	„Există și alte posibilități; avantajele și limitările acestora sunt…"
5 · Rolul dumneavoastră și pasul următor	Ce face pacientul?	„Vă rugăm ca dumneavoastră să… Pasul nostru următor este…"

Valabil în orice situație: nu spune

Expresii precum „garantez", „nu doare deloc", „dacă vă decideți azi", „celălalt medic a greșit", „este un caz foarte ușor", „cu siguranță va fi gata în atâtea luni", „nu va fi nevoie de operație" creează așteptări și distrug încrederea.

CAPITOLUL 2

Clasa I și probleme de spațiu

Relația bazelor osoase este echilibrată; problema constă în alinierea dinților, spațiu și breșe.

În acest capitol se regăsesc cazurile 01–08. Caută cazul în tabel și deschide pagina corespunzătoare.

NR.	TIP CAZ	CUI SE ADRESEAZĂ	MESAJ PRINCIPAL
01	Clasa I, înghesuire ușoară	Pacient (adult)	Ocluzia este echilibrată, problema este alinierea
02	Clasa I, înghesuire medie	Adolescent și părinte	Trebuie creat spațiu, alegem metoda împreună
03	Clasa I, înghesuire severă	Pacient sau părinte	Deficit de spațiu semnificativ; opțiunea extracției cu justificare
04	Protruzie bimaxilară	Pacient (adolescent sau adult)	Dinții și buzele sunt prea în față; discutarea echilibrului
05	Diastemă mediană (adult)	Pacient (adult)	Fără descoperirea cauzei, nu există închiderea spațiului
06	Spațiere generalizată	Pacient	Cauza spațiilor și planul de tratament împreună
07	Deviația liniei mediane	Pacient	Sursa deviației este dentară sau osoasă?
08	Înghesuire în dentiție mixtă (copil)	Părinte	Monitorizare acum sau intervenție acum?

Clasa I, înghesuire ușoară

Cui: Pacient (adult) **Mesaj principal: Ocluzia este echilibrată, problema este alinierea**

Cadru clinic (pentru medic): Relație molară și canină de Clasa I, bază osoasă armonioasă. Înghesuire ușoară în regiunea frontală; se poate rezolva prin stripping (IPR) sau expansiune limitată a arcadelor.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„În urma examinării, relația dintre maxilare și mușcătura dumneavoastră sunt, în ansamblu, echilibrate. Problema constă mai degrabă în alinierea dinților: observ o înghesuire ușoară, în special la dinții din față. Acest lucru poate îngreuna igienizarea spațiilor interdentare și se poate accentua ușor în timp. Scopul tratamentului este de a alinia dinții corect pe arcadă, păstrând în același timp buna mușcătură actuală. În astfel de cazuri, de cele mai multe ori nu este nevoie de extracții dentare. Nu ar fi corect să vă dau un număr exact de luni astăzi; vă pot oferi un interval aproximativ, iar după primele controale vom discuta mai precis. La finalul tratamentului, purtarea aparatului de contenție face parte din menținerea rezultatului. Înainte de a decide, puteți întreba orice vă trece prin minte.”

DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT, CUM EXPLICĂM

Dacă este necesar stripping (IPR): „Vom îndepărta un strat foarte subțire și măsurat de smalț de pe fețele laterale ale dinților. Astfel, câștigăm puțin spațiu fără a extrage dinți. De regulă, nu necesită anestezie; planificăm dinainte cât anume vom îndepărta.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Este foarte simplu, va fi gata repede.	✓ Planul este clar; vom preciza durata după primele controale.
✗ Vă pilim dinții.	✓ Efectuăm o corecție măsurată, foarte subțire, pe fețele laterale.
✗ Contenția nu este obligatorie.	✓ Contenția este ultima etapă, de durată, a tratamentului.

Clasa I, înghesuire medie

Cui: Adolescent și părinte **Mesaj principal: Trebuie creat spațiu, alegem metoda împreună**

Cadru clinic (pentru medic): Relație de Clasa I, înghesuire de grad mediu. Pe baza analizei spațiului, se poate lua în calcul expansiunea, stripping-ul (IPR) sau extracția; profilul și starea gingivală sunt decisive.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Poziția maxilarelor unul față de celălalt este echilibrată, însă spațiul disponibil pentru dinți este ceva mai mic decât lățimea totală a acestora. De aceea, unii dinți au erupt mai în față, mai în spate sau sunt rotiți. Pentru a-i alinia corect, trebuie mai întâi să creăm spațiu. Există mai multe metode pentru acest lucru: expansiunea controlată a arcadei, îndepărtarea unei cantități minime de smalț de pe fețele laterale ale dinților sau, în anumite cazuri, extracția dentară. Decizia privind metoda potrivită o luăm analizând împreună profilul feței, susținerea buzelor și starea gingiilor. Astăzi vă voi prezenta posibilitățile, precum și avantajele și dezavantajele fiecăreia. Indiferent de calea aleasă, controalele regulate, igiena orală corectă și contenția de după tratament reprezintă baza succesului.”

DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT, CUM EXPLICĂM

Dacă apare necesitatea extracției: „Extracția este doar una dintre metodele de câștigare a spațiului. Dacă o recomand, vă voi arăta motivul pe radiografii: necesarul de spațiu și profilul dumneavoastră. Luăm decizia împreună.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Nu se poate fără extracție.	✓ Evaluăm împreună opțiunile și consecințele fiecăreia.
✗ Va fi la fel ca la prietenul tău.	✓ Planul pentru fiecare caz este întocmit pe baza documentației proprii.
✗ Deschidem puțin spațiu și gata.	✓ Există trei modalități de a obține spațiu; o alegem împreună pe cea potrivită pentru dumneavoastră.

Clasa I, înghesuire severă

Cui: Pacient sau părinte

Mesaj principal: Deficit semnificativ de spațiu; opțiunea extracțională cu justificare

Cadru clinic (pentru medic): Deficit semnificativ de spațiu; caninul este în afara arcadei sau dinții sunt înghesuiți. Pe baza analizei de spațiu și a evaluării profilului, planul cu extracții este o opțiune solidă.

CE SĂ ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Lățimea totală a dinților este semnificativ mai mare decât spațiul disponibil pe arcadă. Din acest motiv, unii dinți au fost împinși în afara șirului. În cazul unui deficit atât de mare, dacă aliniem dinții doar prin expansiune, aceștia pot ieși din os sau pot împinge buzele spre înainte. Acest lucru reprezintă un risc pentru sănătatea gingivală și pentru stabilitatea rezultatului pe termen lung. De aceea, pentru cazul dumneavoastră, vă recomand ca opțiune extracția unor dinți. Nu luăm această decizie cu ușurință; am evaluat împreună radiografiile, profilul facial și starea gingiilor. Vă voi explica sincer avantajele și limitările variantei fără extracții. Decizia finală o vom lua împreună cu dumneavoastră."

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„Extracția vizează, de regulă, premolarii; spațiul creat va fi închis prin deplasarea dinților pe parcursul tratamentului. Scopul nostru nu este să rămână spații libere la finalul tratamentului. Vom planifica cine și când va efectua extracția și vă vom oferi detaliile în scris."

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Extragem patru dinți, nu există altă cale.	✓ Pe baza radiografiilor, planul cu extracții este o opțiune solidă; vă voi prezenta și celelalte variante.
✗ Extracția sigur nu îți va strica profilul.	✓ Planul este întocmit ținând cont de profilul dumneavoastră; să discutăm acest aspect pe baza radiografiilor.
✗ Poate rămâne spațiu după, dar nu contează.	✓ Închiderea spațiilor este planificată ca parte a tratamentului.

Protruzie bimaxilară

Cui: Pacient (adolescent sau adult)

Mesaj principal: Dinții și buzele sunt proeminente; scopul este discutarea echilibrului

Cadru clinic (pentru medic): Incisivii superiori și inferiori sunt înclinați spre vestibular, buzele sunt pline și pot prezenta dificultăți în închidere. În decizia de extracție, profilul și așteptările pacientului sunt determinante.

CE SĂ ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Dinții frontali superiori și inferiori sunt ușor înclinați spre înainte în raport cu baza osoasă. Din acest motiv, buzele par și ele mai proeminente și este posibil să depuneți efort pentru a închide gura. Mai întâi, aș dori să vă întreb: vă deranjează ceva la profilul dumneavoastră? În funcție de acest răspuns, planul se poate schimba. Dacă scopul este retracția dinților frontali, avem nevoie de spațiu, iar acest spațiu se obține cel mai adesea prin extracții. Dacă sunteți mulțumit de profilul dumneavoastră, putem discuta un plan mai limitat, care să alinieze dinții în înclinația lor actuală. Vă voi arăta pe radiografii avantajele și limitările ambelor variante. Modificarea aspectului buzelor și al feței diferă de la o persoană la alta; acest lucru nu poate fi garantat cu precizie înainte.”

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„Pentru a putea retrage dinții frontali, trebuie să creăm spațiu în zonele posterioare. Acest spațiu se obține, de cele mai multe ori, prin îndepărtarea premolarilor. Dacă este necesar, putem folosi ancoraj suplimentar, de exemplu mini-implanturi, pentru a preveni deplasarea dinților posteriori spre înainte; vă voi explica acest aspect separat.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Buzele tale sunt foarte proeminente.	✓ Buzele sunt ușor proeminente din cauza înclinației dinților; vă deranjează acest lucru?
✗ Fața ți se va schimba complet.	✓ Modificarea feței diferă de la o persoană la alta; să clarificăm împreună așteptările.
✗ Tratamentul e inutil fără extracții.	✓ Să discutăm comparativ ce oferă planul cu extracții față de cel fără extracții.

Diastemă mediană (adult)

Cui: Pacient (adult) **Mesaj principal: Fără identificarea cauzei, nu există închidere de spațiu**

Cadru clinic (pentru medic): Spațiu între incisivii centrali superiori. De evaluat: frenul, discrepanța de mărime dentară, înclinația incisivilor, dinți lipsă sau cauze parodontale.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Spațiul dintre cei doi dinți din față poate fi închis, dar mai întâi trebuie să înțelegem de ce a apărut. Uneori, frenul buzei pătrunde între dinți, alteori dinții sunt mai mici față de cei vecini, iar în alte cazuri dinții sunt înclinați spre exterior. Starea gingiei și a osului face, de asemenea, parte din această examinare. După clarificarea cauzei, putem închide spațiul prin tratament ortodontic și, dacă este necesar, împreună cu medicul tău dentist, putem corecta și forma dinților. Astfel de spații tind să se redeschidă după închidere. De aceea, îți recomand să aplicăm un fir de contenție fix, subțire, pe suprafața interioară a dinților frontali și să îl menținem pe termen lung."

DACĂ ESTE NECESARĂ EXTRACȚIA SAU UN APARAT, CUM EXPLICĂM

Dacă este necesară o frenectomie sau o completare restauratoare: „Este posibil ca frenul să necesite o mică intervenție de corecție sau ca forma dinților să trebuiască lărgită cu material compozit. Îți voi explica separat ordinea acestor pași și cine se va ocupa de fiecare."

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Îl închidem în două luni și gata.	✓ Mai întâi să căutăm cauza; apoi discutăm despre durată și metodă.
✗ Dacă se închide, nu se mai deschide niciodată.	✓ Aceste spații tind să se redeschidă; de aceea este importantă contenția.
✗ Problema gingivală este vina dumneavoastră.	✓ Evaluăm și protejăm sănătatea gingivală împreună.

Dentație cu spații generalizate

Cui: Pacient **Mesaj principal: Cauza spațiilor și acțiunea comună**

Cadru clinic (pentru medic): Spații interdentare multiple; cauze posibile: discrepanțe de mărime dentară, poziția limbii, protruzia incisivilor sau migrare parodontală.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Ai spații între mulți dintre dinți. Acest lucru apare de obicei dacă dinții sunt mici în raport cu maxilarele, dacă limba împinge dinții sau dacă dinții sunt înclinați în evantai spre exterior. Am verificat și starea gingiei și a osului, deoarece spațiile apar uneori ulterior, ca urmare a unei afecțiuni gingivale. În timpul tratamentului, pe lângă închiderea spațiilor, putem corecta și înclinația dinților frontali. În unele cazuri, se obține un rezultat mai estetic dacă nu închidem toate spațiile, ci lăsăm loc pentru corectarea formei dinților cu material compozit; vom planifica acest lucru împreună cu medicul tău dentist. În cazul dentației cu spații, contenția este deosebit de importantă. Dacă ai obiceiuri linguale, ajută mult la menținerea rezultatului dacă ești conștient de acestea.”

DACĂ ESTE NECESARĂ EXTRACȚIA SAU UN APARAT, CUM EXPLICĂM

„În loc să închidem complet anumite spații, putem lăsa un spațiu calculat pentru corectarea formei dinților. Vom lua această decizie împreună, pe baza proporțiilor dinților vizibile în zâmbetul tău.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ S-au stricat din cauza limbii tale.	✓ Poziția limbii poate influența spațiile; vom monitoriza acest aspect împreună.
✗ Le închidem pe toate, nicio problemă.	✓ Să planificăm împreună, pe baza proporțiilor dentare, ce spații închidem.
✗ Nu va fi nevoie de contenție.	✓ În cazul dentației cu spații, contenția este necesară pentru menținerea rezultatului.

Deviația liniei mediane

Cui: Pacient **Mesaj principal: Sursa deviației este dintele sau maxilarul?**

Cadru clinic (pentru medic): Linia mediană superioară și/sau inferioară este deviată față de linia mediană a feței. Trebuie diferențiat: deviație dentară, deviație funcțională sau asimetrie osoasă.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Mijlocul dinților tăi frontali superiori și inferiori nu este perfect aliniat cu centrul feței tale. Există mai multe cauze posibile: dinții înșiși s-au deplasat, mandibula alunecă într-o parte în momentul închiderii sau, mai rar, există o asimetrie a maxilarelor. În timpul examinării și pe baza radiografiilor, am încercat să identificăm despre ce este vorba. Deviațiile care pornesc de la dinți pot fi corectate de cele mai multe ori prin tratament ortodontic. Dacă există o discrepanță care provine de la maxilare, trebuie să fiu sincer cu tine în privința a ceea ce putem corecta. Uneori, aducerea perfectă a liniei mediane la centru ar fi în detrimentul ocluziei; în astfel de cazuri, o ocluzie sănătoasă și echilibrată este prioritară. Să stabilim împreună, în mod realist, obiectivul tratamentului."

DACĂ ESTE NECESARĂ EXTRACȚIA SAU UN APARAT, CUM EXPLICĂM

Dacă este necesară mecanică asimetrică sau ancoraj suplimentar: „Pentru a mișca dinții diferit pe o parte față de cealaltă, putem folosi elastice sau mini-implanturi. Îți voi arăta pas cu pas cum trebuie folosite."

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Vom aduce linia mediană la milimetru.	✓ Scopul nostru este o ocluzie echilibrată; să discutăm până unde putem ajunge cu linia mediană.
✗ Ai mandibula strâmbă.	✓ Pe radiografii vedem o mică diferență între cele două părți; îți voi explica ce înseamnă.
✗ Oricum nu observă nimeni.	✓ Dacă acest aspect este important pentru dumneavoastră, să îl includem printre obiective.

Înghesuire în dentația mixtă (copil)

Către: Părinte **Mesaj principal: Observare sau intervenție acum?**

Cadru clinic (pentru medic): Perioada dentiției mixte, înghesuire în zona frontală. Analiza spațiului, starea dinților temporari și ordinea erupției determină dacă se optează pentru observare sau intervenție limitată.

CE SĂ ÎI SPUNEM PĂRINTELUI

„În gura copilului dumneavoastră există în prezent atât dinți temporari, cât și dinți permanenți. Înghesuirea vizibilă la nivelul dinților frontali este frecventă în această perioadă și o parte din aceasta se poate reduce pe măsură ce maxilarele cresc și dinții temporari sunt înlocuiți. Totuși, dacă deficitul de spațiu este semnificativ, prin câteva măsuri simple putem facilita tratamentul ulterior. Pe baza radiografiilor de astăzi, voi recomanda fie o monitorizare periodică, fie o intervenție limitată, și vă voi explica motivele. Dacă decidem să optăm pentru monitorizare, aș dori să subliniez că acest lucru nu înseamnă că «nu facem nimic»: verificăm și urmărim erupția dinților la intervale stabilite. Protejarea dinților temporari împotriva cariilor este, de asemenea, importantă, deoarece un dinte temporar pierdut prematur poate reduce spațiul pentru dintele permanent. Ascult cu plăcere întrebările dumneavoastră și opinia copilului.”

DACĂ ESTE NECESARĂ O EXTRACȚIE SAU UN APARAT, CUM EXPLICĂM

Dacă este necesar un menținător de spațiu sau un aparat limitat: „Folosim acest aparat pentru a păstra sau pentru a lărgi ușor spațiul unde urmează să erupă dinții permanenți. Acesta nu este un tratament definitiv; scopul său este de a facilita tratamentul ulterior.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Dacă așteptăm, dinții lui se vor strica sigur.	✓ Unele înghesuiri se pot reduce de la sine; le urmărim prin controale periodice.
✗ Dacă începem acum, mai târziu nu va mai avea nevoie de aparat.	✓ Intervenția timpurie poate facilita tratamentul ulterior; trebuie să știți că ar putea fi nevoie de tratament și mai târziu.
✗ Este încă prea devreme, nu se poate face nimic.	✓ Urmărirea acestei perioade prin vizite de control reprezintă, de asemenea, un plan de tratament.

MODULUL 03

Cazuri Clasa II

Clasa II la copil, adolescent și adult; posibilitățile de creștere și limitele compensării.

În acest capitol se regăsesc cazurile 09–16. Caută cazul în tabel și deschide pagina corespunzătoare.

NR.	TIP DE CAZ	CĂTRE	MESAJ PRINCIPAL
09	Clasa II diviziunea 1, copil	Părinte	Potențialul de creștere; cooperarea este decisivă
10	Clasa II diviziunea 1, adolescent	Adolescent și părinte	Utilizarea optimă a puseului de creștere
11	Clasa II diviziunea 1, adult	Pacient (adult)	Fără creștere; compensare cu limitele sale
12	Clasa II, adult, limită chirurgicală	Pacient (adult)	Comparație sinceră între compensare și chirurgie
13	Clasa II diviziunea 2, copil	Părinte	Incisivi verticalizați și ocluzie adâncă; observare sau corecție timpurie
14	Clasa II diviziunea 2, adult	Pacient (adult)	Efectul ocluziei adânci asupra dinților și gingiei
15	Clasa II dentară, bază osoasă armonioasă	Pacient	Problema nu este maxilarul, ci poziția dinților; posibilitate de distalizare
16	Overjet mărit, risc de traumatism (copil)	Părinte	Dinții proeminenți sunt expuși loviturilor

Clasa II diviziunea 1, copil

Către: Părinte **Mesaj principal: Potențialul de creștere; cooperarea este decisivă**

Cadru clinic (pentru medic): Copil în creștere; overjet mărit, impresia de mandibulă retrognată. Aparat funcțional sau observare; cooperarea și stadiul de creștere sunt decisive.

CE SĂ ÎI SPUNEM PĂRINTELUI

„Dinții frontali superiori ai copilului dumneavoastră sunt poziționați mult în fața celor inferiori. Pe radiografii vedem că o parte semnificativă din acest aspect este legată de faptul că mandibula este situată mai în spate față de maxilar. Copilul dumneavoastră este încă în perioada de creștere, iar acest lucru ne oferă o oportunitate: cu anumite aparate putem încerca să susținem direcția de creștere. Efectul acestor aparate depinde în mare măsură de purtarea lor regulată, adică rezultatul depinde și de contribuția copilului și a dumneavoastră. Nu putem ști dinainte cu certitudine cât va contribui creșterea, de aceea urmărim progresul prin măsurători la controale. După această etapă, ar putea fi necesar un tratament cu aparat fix pentru alinierea dinților. Să discutăm împreună care este momentul potrivit."

DACĂ ESTE NECESARĂ O EXTRACȚIE SAU UN APARAT, CUM EXPLICĂM

„Aparatul funcțional acționează menținând mandibula ușor mai în față. În primele zile, vorbirea și mâncatul pot fi puțin neobișnuite; majoritatea copiilor se obișnuiesc în câteva săptămâni. Vă voi înmâna în scris informații despre durata purtării."

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Cu acest aparat, mandibula va veni sigur în față.	✓ Urmărim susținerea creșterii; îi vom măsura efectul la controale.
✗ Dacă nu îl poartă, este vina dumneavoastră.	✓ Haideți să stabilim împreună o rutină pentru purtarea regulată.
✗ După aceea nu mai este nevoie de aparat dentar.	✓ După această etapă, ar putea fi necesar un tratament fix; aș dori să știi acest lucru încă de la început.

Clasa II diviziunea 1, adolescent

Cui: Adolescent și părinte **Mesaj principal: Valorificarea optimă a puseului de creștere**

Cadru clinic (pentru medic): Adolescent în puseul de creștere sau aproape de acesta; overjet mărit. Pe lângă tratamentul fix, posibilitatea suportului funcțional, elastice de Clasa II sau plan de tratament cu extracții.

CE SĂ ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Faptul că dinții frontali superiori sunt poziționați în fața celor inferiori influențează atât aspectul estetic, cât și faptul că dinții frontali sunt mai vulnerabili în cazul unor traumatisme. Copilul dumneavoastră se află acum în perioada de creștere rapidă; aceasta poate fi o oportunitate importantă pentru a corecta, odată cu tratamentul, și diferența dintre maxilar și mandibulă. În planul nostru, pe lângă tratamentul fix pentru alinierea dinților, pot fi incluse elastice sau aparate care ajută la corectarea relației dintre oasele maxilare. Succesul acestora depinde în mare măsură de purtarea lor constantă, motiv pentru care rolul pacientului și susținerea de acasă sunt esențiale. Uneori, această cale nu este suficientă și poate apărea necesitatea unui plan de compensare prin extracții; aș dori să discutăm deschis despre această posibilitate încă de la început. Puteți adresa orice întrebări, atât dumneavoastră, cât și pacientul."

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„Elasticele de Clasa II sunt mici benzi de cauciuc pe care le atașăm între arcada superioară și cea inferioară. Pacientul le schimbă singur în fiecare zi. În primele zile, poate apărea o senzație de presiune la nivelul dinților; aceasta dispare de obicei în câteva zile."

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Dacă nu porți elasticele, tratamentul se va prelungi, să nu te plângi la mine după aceea.	✓ Purtarea constantă a elasticelor scurtează drumul către finalizare; anunță-mă dacă într-o zi nu ai reușit să le porți și vom găsi împreună o soluție.
✗ Vom repara complet maxilarul.	✓ Obiectivul nostru este reducerea diferenței dintre oasele maxilare; vom măsura progresul pe parcurs.
✗ Creșterea s-a încheiat, este deja prea târziu.	✓ Vom evalua stadiul de creștere pe baza radiografiilor și vom discuta opțiunile disponibile.

Clasa II diviziunea 1, adult

Cui: Pacient (adult) **Mesaj principal: Fără creștere; limitele compensării**

Cadru clinic (pentru medic): Adult cu creștere finalizată; relație de Clasa II, overjet mărit. Opțiuni: compensare dentară (prin extracții sau distalizare), tratament combinat cu chirurgie sau tratament limitat.

CE SĂ ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Dinții dumneavoastră frontali superiori sunt poziționați vizibil în fața celor inferiori; pe radiografii observăm că o parte din această problemă ține de poziția oaselor maxilare. Deoarece creșterea dumneavoastră s-a încheiat, nu mai putem modifica poziția oaselor cu ajutorul aparatelor. În schimb, există două căi principale. Prima: adaptăm poziția dinților la oasele maxilare; pentru aceasta, de cele mai multe ori este necesară extracția unor dinți sau deplasarea dinților posteriori spre distal. A doua: dacă diferența este mare, combinăm tratamentul ortodontic cu chirurgia ortognată. Astăzi doresc să vă explic deschis care cale este realistă pentru dumneavoastră, ce anume corectăm și ce nu. De asemenea, trebuie să cunosc așteptările dumneavoastră privind aspectul facial."

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„În planul cu extracții, de obicei extragem premolarii superiori și retragem dinții frontali. Pentru ca dinții posteriori să nu migreze nedorit spre mezial, poate fi necesar un ancoraj suplimentar, de exemplu un mini-implant; este o intervenție minoră, care va fi îndepărtată la finalul tratamentului."

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Mandibula dumneavoastră este prea în spate, dar o rezolvăm cu aparatul.	✓ Aparatul modifică poziția dinților; opțiunile privind poziția oaselor maxilare le vom discuta separat.
✗ Dacă nu doriți operație, nicio problemă, va fi la fel.	✓ Vă voi arăta deschis ce corectează și ce nu planul fără intervenție chirurgicală.
✗ Ați depășit deja limita de vârstă.	✓ Tratamentul este posibil și la vârsta adultă; doar opțiunile sunt diferite.

Clasa II, adult, caz limită chirurgical

Cui: Pacient (adult) **Mesaj principal: Comparație onestă între compensare și chirurgie**

Cadru clinic (pentru medic): Discrepanță osoasă marcată; caz limită între compensare și chirurgia ortognată. Trebuie discutate profilul, problemele respiratorii, așteptările pacientului și percepția riscurilor.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„În cazul dumneavoastră, discrepanța dintre oasele maxilare este aproape de limita până la care poate fi compensată complet doar prin mișcarea dinților. De aceea, aș dori să analizăm împreună două căi. Prima cale: aliniem dinții în raport cu oasele maxilare doar prin tratament ortodontic. Aceasta poate îmbunătăți ocluzia, însă nu va modifica semnificativ profilul facial, iar mișcarea dinților poate fi dusă aproape de limitele lor fiziologice. A doua cale: combinăm tratamentul ortodontic cu chirurgia ortognată. Aceasta abordează și poziția oaselor maxilare, însă intervenția chirurgicală are propriul flux, timp de recuperare și riscuri. Care dintre aceste căi vi se potrivește, trebuie să decidem în funcție de prioritățile dumneavoastră. Dacă doriți, pentru opțiunea chirurgicală, vom solicita și opinia unui medic specialist în chirurgie oro-maxilo-facială.”

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„În planul combinat cu chirurgia, mai întâi pregătim dinții pentru operație, apoi urmează intervenția chirurgicală, iar la final, finisarea ortodontică. În etapa preoperatorie, aspectul estetic poate deveni temporar mai accentuat; acesta este un pas prevăzut în planul de tratament.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Dacă nu acceptați operația, nu am ce să fac.	✓ Haideți să discutăm împreună ce oferă cele două opțiuni; decizia vă aparține.
✗ Operația este foarte simplă.	✓ Intervenția chirurgicală are un flux și riscuri specifice; să le evaluăm împreună cu opinia medicului specialist.
✗ Obținem același rezultat și cu aparatul dentar.	✓ Tratamentul ortodontic îmbunătățește ocluzia; modificarea profilului poate fi limitată.

Clasa II diviziunea 2, copil

Cui: Părinte **Mesaj principal: Incisivi înclinați și ocluzie adâncă; monitorizare sau corecție timpurie**

Cadru clinic (pentru medic): Incisivii centrali superiori înclinați palatinal, incisivii laterali înclinați vestibular; ocluzie adâncă. Dentație mixtă sau timpurie permanentă. Corecția înclinării incisivilor și monitorizarea adâncimii ocluziei.

CE ÎI SPUNEM PĂRINTELUI

„Doi dintre dinții din față ai copilului dumneavoastră sunt înclinați spre interior, iar dinții de lângă ei sunt înclinați spre exterior. Aceasta este o stare care implică o acoperire excesivă a dinților inferiori de către cei superiori. Uneori, dinții inferiori se închid aproape de suprafața internă a dinților superiori sau de palat. Această situație nu tinde să se rezolve de la sine. La unii copii, un aparat simplu, care corectează înclinarea dinților frontali, poate ajuta mandibulă să se miște mai liber și poate facilita tratamentul ulterior. La alții, monitorizarea controlată până la erupția completă a dinților permanenți este mai potrivită. Astăzi vă voi spune ce cale îi recomand copilului dumneavoastră și de ce. Vom monitoriza la fiecare control eventualele iritații ale gingiei sau ale palatului.”

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„Aparatul pe care îl folosim este conceput pentru a corecta înclinarea dinților frontali spre exterior. În primele zile, copilul ar putea vorbi puțin mai greu. Vă voi oferi un ghid scris despre curățarea aparatului și timpul de purtare.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Acești dinți sunt foarte strâmbi.	✓ Dinții frontali sunt înclinați spre interior; vă voi explica cum se poate corecta acest lucru.
✗ Dacă nu facem nimic, i se va strica maxilarul.	✓ Această stare nu tinde să se rezolve de la sine; haideți să alegem împreună când să intervenim.
✗ Totul se rezolvă cu un singur aparat.	✓ Aș dori să știți de la început că, ulterior, ar putea fi necesar un tratament cu aparat fix.

Clasa II diviziunea 2, adult

Cui: Pacient (adult) **Mesaj principal: Impactul ocluziei adânci asupra dinților și gingiei**

Cadru clinic (pentru medic): Adult; incisivi superiori înclinați palatinal, ocluzie adâncă, eventuală uzură a incisivilor inferiori sau iritație palatinală. Plan pentru corecția înclinării incisivilor și deschiderea ocluziei.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Dinții dumneavoastră frontali superiori sunt înclinați spre interior și, în ocluzie, acoperă dinții inferiori mai mult decât ar fi necesar. Unele consecințe le observăm deja la examinare, cum ar fi uzura dinților frontali inferiori sau sensibilitatea palatului. Scopul tratamentului este să corectăm înclinarea dinților frontali și să reducem adâncimea ocluziei. Astfel, dorim să echilibrăm contactul dintre dinți. La vârsta adultă, deschiderea unei astfel de ocluzii poate necesita timp, iar pentru menținerea rezultatului trebuie să acordăm o atenție deosebită contenției după tratament. Starea gingiei face, de asemenea, parte din plan. Nu pot spune dinainte dacă tratamentul va elimina durerile articulare; doresc să fiu transparent în această privință."

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„Pentru deschiderea ocluziei, trebuie să orientăm dinții frontali ușor spre interior și în sus. În unele cazuri, folosim pe dinții posteriori mici înălțătoare de ocluzie sau ancoraj suplimentar, cum ar fi mini-implanturi. Acestea sunt temporare și vi le vom explica separat."

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Cu acest tratament va trece durerea de articulație.	✓ Nu pot spune dinainte cum va influența tratamentul ortodontic simptomele articulare; le vom evalua separat.
✗ Dinții se tocesc.	✓ Există semne de uzură pe dinții frontali inferiori; haideți să discutăm despre un plan care să oprească acest proces.
✗ Această ocluzie se va menține de la sine după tratament.	✓ Ocluzia adâncă tinde să recidiveze; de aceea, contenția este esențială.

Clasa II dentară, bază osoasă armonioasă

Cui: Pacient **Mesaj principal: Problema nu este maxilarul, ci poziția dinților; posibilitate de distalizare**

Cadru clinic (pentru medic): Relația osoasă este acceptabilă; molarii superiori au migrat mezial (ex. după pierderea precoce a dinților temporari). Distalizare, mecanică susținută cu mini-implanturi sau posibilitatea extracțiilor.

CE SĂ ÎI SPUI PACIENTULUI

„Poziția maxilarelor tale este în limite acceptabile. Problema provine mai degrabă din faptul că dinții posteriori superiori au migrat în timp spre față; acest lucru reduce spațiul pentru dinții frontali și modifică ocluzia. În acest caz, putem lua în considerare deplasarea controlată a molarilor superiori spre distal. Pentru aceasta, în anumite situații, folosim dispozitive auxiliare mici, cum ar fi mini-implanturile; acestea previn mișcarea dinților în direcții nedorite. O altă variantă este obținerea spațiului prin extracția unor dinți. Haideți să discutăm avantajele și dezavantajele ambelor variante din punctul de vedere al duratei, confortului și rezultatului. Succesul planului ales depinde și de respectarea controalelor periodice.”

DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU DISPOZITIV, CUM EXPLICĂM

„Mini-implantul este un șurub foarte mic, temporar, pe care îl inserăm în osul dintre dinți. Se poate insera sub anestezie, într-un timp scurt, și îl vom îndepărta la finalul tratamentului. În primele zile, poate exista o ușoară sensibilitate în zonă.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	SPUNE ÎN SCHIMB
✗ Punem un șurub, nu ai de ce să te temi.	✓ Îți voi explica ce este mini-implantul, cum îl inserăm și ce ai putea simți.
✗ Tragem dinții înapoi cât de mult vrem.	✓ Cât de mult îi putem deplasa spre distal depinde de radiografiile tale.
✗ Soluția cu extracții este învechită.	✓ Ambele variante sunt potrivite în anumite cazuri; haideți să discutăm care se potrivește mai bine pentru dumneavoastră.

Overjet mărit, risc de traumatism (copil)

Cui: Părinte **Mesaj principal: Dinții proeminenți sunt expuși riscului de lovituri**

Cadru clinic (pentru medic): Overjet accentuat, incompetență labială; risc de traumatism al incisivilor. Se ia în considerare intervenția precoce (aparat sau tratament limitat) și măsuri de protecție.

CE SĂ ÎI SPUI PĂRINTELUI

„Dinții frontali superiori ai copilului dumneavoastră sunt vizibil proeminenți, iar buzele nu îi pot acoperi complet. În acest caz, în urma unei căzături sau a unui impact, riscul de a deteriora dinții frontali este mai mare. De aceea, trebuie să analizăm momentul începerii tratamentului nu doar din punct de vedere estetic, ci și pentru protecția dinților. La unii copii, tratamentul precoce cu aparat poate îmbunătăți poziția dinților frontali și poate reduce acest risc. Dacă practică sport, este important să folosească o gutieră de protecție. Tratamentul precoce nu face întotdeauna inutilă o a doua etapă de tratament mai târziu; aș dori să știți acest lucru de la început. De asemenea, notați că, dacă un dinte frontal suferă un impact, trebuie să vă prezentați imediat la medicul dentist."

DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU DISPOZITIV, CUM EXPLICĂM

„Scopul tratamentului precoce cu aparat este de a îmbunătăți poziția dinților frontali și de a susține relația dintre maxilare. Respectarea timpului de purtare influențează direct rezultatul; putem face împreună un tabel de monitorizare."

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	SPUNE ÎN SCHIMB
✗ Dinții lui se pot rupe oricând.	✓ Dinții frontali sunt mai expuși la lovituri; haideți să discutăm cum putem reduce riscul.
✗ Dacă începem devreme, nu va mai fi nevoie de un al doilea tratament.	✓ Tratamentul precoce poate reduce riscurile; ulterior, ar putea fi necesară o a doua etapă.
✗ Nu îl lăsați să facă sport.	✓ Poate continua să facă sport fără probleme; vă recomand să poarte o gutieră de protecție.

MODULUL 4

Cazuri Clasa III

Clasa III pseudo, osoasă reală și limită chirurgicală; prezentarea onestă a creșterii.

În acest capitol se află cazurile 17–21. Caută cazul în tabel și deschide pagina corespunzătoare.

NR.	TIP DE CAZ	CUI	MESAJ PRINCIPAL
17	Clasa III pseudo (copil)	Părinte	Ocluzie inversă cauzată de alunecarea spre anterior; logica corecției precoce
18	Clasa III osoasă reală (copil)	Părinte	Șansa ortopediei precoce; rezultatul depinde de creștere
19	Clasa III, adolescent, monitorizarea creșterii	Adolescent și părinte	Cât timp creșterea continuă, decizia poate fi amânată
20	Clasa III, adult, compensare	Pacient (adult)	Alinierea dinților este posibilă; modificarea profilului este limitată
21	Clasa a III-a, limită chirurgicală	Pacient (adult)	Opțiunea chirurgicală prezentată onest, fără presiune

Pseudo-Clasa a III-a (copil)

Către: Părinte

Mesaj principal: Ocluzie inversă cauzată de propulsia mandibulară; logica corecției precoce

Cadru clinic (pentru medic): Ocluzie inversă frontală; în relație centrică se poate obține contact cap-la-cap. Propulsie funcțională; corecția precoce este de obicei indicată.

CE SĂ ÎI SPUI PĂRINTELUI

„Dinții frontali inferiori ai copilului dumneavoastră ajung în fața dinților superiori în momentul închiderii gurii. În timpul examinării, am observat că, atunci când închide gura lent, dinții frontali pot ajunge într-o poziție cap-la-cap. Din acest motiv, credem că o mare parte a problemei provine din poziția dinților și din faptul că mandibula alunecă spre înainte în momentul închiderii. În astfel de cazuri, recomandăm de obicei o corecție precoce, deoarece, dacă ocluzia inversă persistă, dinții și țesuturile înconjurătoare pot fi afectate. Tratamentul durează, de cele mai multe ori, puțin timp și se realizează cu aparate simple. Cu toate acestea, vom monitoriza creșterea copilului dumneavoastră la controale, deoarece dorim să vedem cum evoluează situația pe măsură ce crește. Dacă aveți întrebări, haideți să le discutăm acum.”

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„Scopul aparatului pe care îl folosim este de a împinge dinții frontali superiori ușor spre înainte, astfel încât aceștia să ajungă în fața dinților inferiori. Uneori, aplicăm înălțătoare de ocluzie pe dinții posteriori; acest lucru este necesar pentru ca dinții frontali să se poată mișca liber.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	SPUNE ÎN SCHIMB
✗ Este simplu, după aceea nu va mai avea niciodată probleme.	✓ Tratamentul este de obicei scurt; vom monitoriza creșterea la controale, indiferent de acest aspect.
✗ Îi sare maxilarul.	✓ Mandibula alunecă spre înainte la închidere; vă explic care este cauza.
✗ Putem să mai așteptăm.	✓ În cazul unei astfel de ocluzii inverse, recomandăm de obicei o corecție precoce; vă explic de ce.

Clasa a III-a scheletală reală (copil)

Către: Părinte **Mesaj principal: Ortopedia precoce ca oportunitate; rezultatul depinde de creștere**

Cadru clinic (pentru medic): Semne de Clasa a III-a scheletală, dezvoltarea maxilarului este deficitară; copil în perioada de creștere. Posibilitatea utilizării RME și a măștii faciale; trebuie evaluat istoricul familial și direcția de creștere.

CE SĂ ÎI SPUI PĂRINTELUI

„Pe radiografii observăm că maxilarul copilului dumneavoastră este în urmă față de mandibulă. Dincolo de dinți, acest lucru ține de dezvoltarea oaselor maxilare. În perioada de creștere, putem folosi aparate ortopedice care susțin dezvoltarea maxilarului. Acestea pot include un aparat de expansiune a maxilarului și o mască facială purtată în principal noaptea. Există un aspect pe care trebuie să vi-l spun onest: în astfel de cazuri, creșterea continuă și în anii următori, iar cât de durabil va fi rezultatul depinde de direcția acestei creșteri. De aceea, vom monitoriza situația periodic, iar ulterior ar putea fi nevoie de tratamente complementare sau chiar de chirurgie ortognată după finalizarea creșterii. De asemenea, aș dori să știu dacă a mai existat o situație similară în familie.”

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„Aparatul de expansiune se fixează pe bolta palatină; trebuie activat la intervale stabilite, conform modului în care v-am arătat. Masca facială este utilizată mai mult acasă și pe timpul nopții. Purtarea regulată influențează direct rezultatul. Haideți să planificăm împreună în ce intervale orare să o poarte.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	SPUNE ÎN SCHIMB
✗ Cu masca, maxilarul se va repara complet.	✓ Scopul nostru este să susținem dezvoltarea maxilarului; vom monitoriza creșterea timp de mai mulți ani.
✗ Dacă începem devreme, sigur nu va fi nevoie de operație.	✓ Tratamentul precoce este o oportunitate; trebuie să știți că, ulterior, ar putea fi nevoie și de operație.
✗ Dacă nu poartă masca, nu are efect; este decizia dumneavoastră.	✓ Haideți să facem un plan împreună pentru ca cel mic să se obișnuiască cu masca.

Clasa a III-a, adolescent, monitorizarea creșterii

Către: Adolescent și părinte **Mesaj principal: Cât timp creșterea continuă, decizia poate fi amânată**

Cadru clinic (pentru medic): Adolescent; tendință de Clasa a III-a scheletală ușoară-moderată, creșterea continuă. Compensarea precoce poate fi riscantă; monitorizarea și evaluarea la finalul creșterii reprezintă o opțiune.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Pe radiografii observăm că mandibula este poziționată ușor anterior față de maxilar. Deoarece creșterea este încă în desfășurare, nu putem ști cu exactitate cum se va modifica acest raport în următorii ani; creșterea mandibulei poate continua uneori până la finalul adolescenței. Prin urmare, în loc să luăm o decizie definitivă acum, vă pot propune un tratament limitat sau o monitorizare controlată care să mențină dinții într-o stare corectă. Când creșterea încetinește, vom face din nou radiografii și vom evalua dacă continuăm doar cu tratament ortodontic sau dacă chirurgia ortognată reprezintă o opțiune. Această perioadă de așteptare nu este timp pierdut; este necesară pentru a putea lua o decizie corectă. Opinia dumneavoastră și a familiei este, de asemenea, importantă pentru mine.”

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„Tratamentul aplicat în această etapă vizează alinierea dinților și corectarea ocluziei. Decizia principală o vom lua atunci când creșterea încetinește și vom efectua noi radiografii. Vă voi înmâna acest plan și în scris.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Dacă mai crește, îl operăm.	✓ Când creșterea încetinește, vom reevalua opțiunile.
✗ Dacă punem aparatul acum, nu vor mai fi probleme.	✓ Pe măsură ce creșterea continuă, anumite rezultate se pot modifica; de aceea monitorizăm.
✗ Pierdem timpul așteptând.	✓ Această perioadă de monitorizare este o etapă necesară pentru a lua decizia corectă.

Clasa III, adult, compensare

Cui: Pacient (adult)

Mesaj principal: Alinierea dinților este posibilă; modificarea profilului facial este limitată

Cadru clinic (pentru medic): Adult; Clasa III scheletală ușoară-moderată, în limitele compensării. Retruzia incisivilor inferiori, proclinarea incisivilor superiori; trebuie luate în considerare limitele parodontale și osoase.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Mandibula dumneavoastră este poziționată ușor anterior față de maxilar. Deoarece creșterea este finalizată, nu mai putem modifica acest raport prin aparate ortodontice; gradul diferenței pare însă a fi adecvat pentru a corecta ocluzia prin ajustarea poziției dinților. În acest plan, ne propunem să deplasăm ușor spre anterior dinții frontali superiori și ușor spre posterior pe cei inferiori. Există o limită: dinții se pot deplasa doar atât cât permite suportul osos și gingival. De aceea, nu ar fi corect să vă așteptați la o schimbare majoră a profilului facial. Dacă profilul este prioritatea dumneavoastră, putem discuta separat despre posibilitatea unui tratament combinat cu chirurgia ortognată. Să stabilim împreună ce variantă corespunde așteptărilor dumneavoastră."

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„În acest plan, uneori este nevoie de extracții la nivelul arcadei inferioare sau de ancoraj suplimentar, de exemplu mini-implanturi, pentru a crea spațiu. De asemenea, vom folosi elastice intermaxilare. Vă voi explica motivul pentru fiecare și vă voi arăta pas cu pas cum se utilizează."

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Vă vom trage mandibula mai în spate.	✓ Vom ajusta poziția dinților în raport cu oasele maxilare; poziția oaselor nu se modifică.
✗ Și profilul se va repara.	✓ Modificarea profilului poate fi limitată; să clarificăm așteptările.
✗ Operația este inutilă.	✓ Operația este opțiunea corectă pentru anumiți pacienți; dacă va fi nevoie, vă voi informa.

Clasa III, limită chirurgicală

Cui: Pacient (adult) **Mesaj principal: Opțiunea chirurgicală prezentată onest, fără presiune**

Cadru clinic (pentru medic): Clasa III scheletală severă, posibilă asimetrie; la limita sau dincolo de limitele compensării. Trebuie luată în considerare abordarea combinată cu chirurgia ortognată; consult de chirurgie oro-maxilo-facială.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Pe radiografiile dumneavoastră observăm că diferența dintre mandibulă și maxilar este destul de pronunțată. Dacă am încerca să compensăm o asemenea diferență doar prin deplasarea dinților, am putea forța dinții dincolo de limitele suportului osos, iar aspectul feței s-ar modifica foarte puțin. De aceea, aș dori să vă prezint și un plan care combină ortodonția cu chirurgia ortognată. Aceasta nu este obligatorie, ci o opțiune. Operația are o etapă de pregătire, o parte spitalicească și o perioadă de recuperare; riscurile și beneficiile trebuie explicate în detaliu de către medicul chirurg. Dacă nu doriți operația, vom discuta deschis și despre ce poate oferi un plan ortodontic limitat. Este important să analizați totul fără grabă.”

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„În planul combinat, tratamentul ortodontic începe înaintea operației și pregătește dinții pentru intervenția chirurgicală. În această perioadă, ocluzia poate părea temporar mai accentuată. După operație, urmează o etapă scurtă de finisare ortodontică. Să ne pregătim împreună pentru consultul de specialitate.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Singura soluție este operația.	✓ Planul combinat cu chirurgia este o opțiune; îți voi explica și limitele planului fără intervenție chirurgicală.
✗ Operația este foarte ușoară, nu vă temeți.	✓ Procesul și riscurile operației trebuie explicate detaliat de către medicul specialist.
✗ Trebuie să decideți imediat.	✓ Este important să decideți fără grabă, după ce v-ați informat.

MODULUL 05

Probleme Verticale și Transversale

Ocluzie deschisă, ocluzie adâncă, ocluzie inversă și ocluzie în foarfecă.

În acest capitol se află cazurile 22–28. Caută cazul în tabel și deschide pagina corespunzătoare.

NR.	TIP DE CAZ	CUI SE ADRESEAZĂ	MESAJ PRINCIPAL
22	Ocluzie deschisă frontală, copil (obicei)	Părinte și copil	Mai întâi obiceiul, apoi dinții
23	Ocluzie deschisă frontală, adult	Pacient (adult)	Cauză multifactorială; riscul de recidivă, explicat deschis
24	Ocluzie adâncă	Pacient sau părinte	Supraocluzia excesivă solicită dinții și gingiile
25	Ocluzie inversă posterioară unilaterală (copil)	Părinte	Maxilar îngust și deviere laterală; corecție timpurie
26	Maxilar îngust, adult	Pacient (adult)	Dacă sutura este osificată, opțiunile sunt diferite
27	Ocluzie inversă frontală pe un singur dinte	Pacient sau părinte	Dinte blocat; soluție timpurie pentru sănătatea dintelui și a gingiei
28	Ocluzie în foarfecă	Pacient	Dinți posteriori înclinați spre exterior; plan detaliat

Ocluzie deschisă frontală, copil (obicei)

Cui: Părinte și copil **Mesaj principal: Mai întâi obiceiul, apoi dinții**

Cadru clinic (pentru medic): Ocluzie deschisă frontală în dentiție mixtă; suptul degetului, suzeta sau interpoziția linguală în anamneză. Eliminarea obiceiului și, dacă este necesar, aparat de stopare a obiceiului.

CE SĂ ÎI SPUNEM PACIENTULUI / PĂRINTELUI

„Când copilul dumneavoastră închide gura, dinții din față nu se ating; rămâne un spațiu între ei. La această vârstă, acest lucru este legat de cele mai multe ori de suptul degetului, de poziția buzei sau a limbii. Primul și cel mai important pas este reducerea acestui obicei. Cât timp obiceiul persistă, efectul tratamentului nostru poate rămâne limitat. Acest lucru se obține mult mai eficient dacă nu certăm copilul, ci îl recompensăm și îl susținem. Dacă este necesar, putem folosi un aparat simplu care să îi reamintească să nu mai facă acest lucru. La unii copii, după încetarea obiceiului, spațiul se poate reduce de la sine, la alții este nevoie de tratament suplimentar. Dacă observați probleme legate de vorbire sau deglutiție, le putem evalua împreună."

DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT, CUM EXPLICĂM

„Aparatul de stopare a obiceiului este un dispozitiv mic care îngreunează presiunea limbii sau a degetului asupra dinților frontali. Nu este o pedeapsă; trebuie prezentat copilului ca un memento. În primele zile, vorbirea și mâncatul pot necesita o perioadă de adaptare."

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB, SPUNE
✗ Dacă nu se lasă de suptul degetului, i se vor strica dinții.	✓ Pe măsură ce obiceiul scade, tratamentul funcționează mai bine; să îl susținem împreună.
✗ Acest aparat este o pedeapsă ca să nu-și mai sugă degetul.	✓ Acest aparat este un memento.
✗ Se va rezolva de la sine.	✓ La unii copii se poate reduce; vom monitoriza la controale.

Ocluzie deschisă frontală, adult

Cui: Pacient (adult) **Mesaj principal: Cauză multifactorială; riscul de recidivă, explicat deschis**

Cadru clinic (pentru medic): Ocluzie deschisă frontală la adult; factori posibili: direcție de creștere osoasă verticală, poziția limbii, anamneză respiratorie. Opțiuni mecanice: intruzie susținută cu mini-implanturi, extruzie, chirurgie.

CE SĂ ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Când închideți gura, dinții din față nu se ating. La vârsta adultă, acest lucru are de obicei mai multe cauze: structura verticală a oaselor maxilare, poziția de repaus a limbii sau obiceiuri din trecut. Scopul tratamentului este ca dinții frontali să intre în contact și să se îmbunătățească funcția ocluziei. Pentru aceasta există mai multe opțiuni: intruzia ușoară a dinților posteriori, extruzia ușoară a dinților frontali sau, în cazul unei discrepanțe mari, combinația cu chirurgia ortognată. Vreau să vă spun deschis că, după tratament, acest tip de ocluzie are o tendință parțială de a recidiva. De aceea, contenția și, dacă este cazul, tratamentul obiceiurilor linguale vor face parte din plan. Să discutăm împreună care opțiune este realistă pentru dumneavoastră.”

DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT, CUM EXPLICĂM

„Pentru intruzia ușoară a dinților posteriori, putem folosi mini-implanturi ca ancoraj. Acestea sunt șuruburi mici, temporare, inserate între dinți, pe care le vom îndepărta la finalul tratamentului. Pe radiografii vă voi arăta în ce zonă vor fi plasate și de ce.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB, SPUNE
✗ Odată ce această ocluzie a fost corectată, rezultatul este definitiv.	✓ Ocluzia deschisă poate avea tendința de a recidiva; de aceea este importantă contenția.
✗ S-a format din cauza limbii.	✓ Poziția limbii poate contribui; am evaluat și celelalte cauze împreună.
✗ Nu e nevoie de operație, nu vă îngrijorați.	✓ În funcție de amploarea anomaliei, trebuie să discutăm și despre opțiunea chirurgicală.

Ocluzie adâncă

Cui: Pacient sau părinte **Mesaj principal: Supraocluzia excesivă solicită dinții și gingiile**

Cadru clinic (pentru medic): Overbite pronunțat; incisivii inferiori ating mucoasa palatinală sau fețele palatinale ale incisivilor superiori. Curba Spee poate fi accentuată. Posibilitatea intruziei incisivilor, extruziei posterioare.

CE SĂ ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Când închideți gura, dinții frontali superiori acoperă dinții frontali inferiori mai mult decât ar fi normal. Uneori, dinții inferiori se închid atât de adânc, încât ating palatul sau fețele interne ale dinților superiori. Acest lucru poate duce în timp la uzura dinților, sensibilitate palatinală sau modificarea poziției dinților frontali. Scopul tratamentului este să reducem adâncimea ocluziei și să echilibrăm contactul dintre dinții frontali. Pentru aceasta, folosim metode precum intruzia ușoară a dinților frontali, reglarea ocluziei dinților posteriori sau o combinație a celor două. Ocluzia adâncă are tendința de a recidiva după tratament; de aceea, planificăm etapa de contenție încă de la început. Dacă aveți simptome deranjante, aș dori să le ascult mai întâi pe acestea.”

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„În anumite cazuri, aplicăm mici înălțătoare de ocluzie pe dinții posteriori sau pe fețele interne ale dinților frontali superiori. Acestea reduc temporar contactul dintre dinți. În primele zile, senzația la masticație poate fi neobișnuită; de obicei, vă veți obișnui repede cu ele.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Dinții inferiori vă rănesc palatul.	✓ Dinții inferiori se închid aproape de palat; să discutăm despre un plan care să reducă acest lucru.
✗ Ocluzia adâncă nu se corectează de la sine, trebuie să începem imediat.	✓ Să evaluăm împreună efectele acestei ocluzii și momentul optim pentru tratament.
✗ Contenția durează doar câteva luni.	✓ În cazul ocluziei adânci, planificăm o perioadă lungă de contenție.

Ocluzie inversă laterală unilaterală (copil)

Cui: Părinte **Mesaj principal: Maxilar îngust și deviere mandibulară; corecție timpurie**

Cadru clinic (pentru medic): Ocluzie inversă laterală unilaterală, de obicei cu maxilar îngust și deviere mandibulară la închidere. Posibilitate de RME în perioada de creștere.

CE SĂ ÎI SPUNEM PĂRINTELUI

„Când copilul închide gura, dinții posteriori de pe o parte se închid invers, iar mandibula deviază spre acea parte. Motivul este, de cele mai multe ori, faptul că maxilarul superior este ușor îngust. În perioada de creștere, aparatele folosite pentru expansiunea maxilarului dau rezultate bune la această vârstă, deoarece sutura de creștere din centrul maxilarului nu este încă osificată. Dacă această deviere laterală persistă mult timp, poate influența echilibrul dezvoltării maxilarelor; de aceea, recomand o corecție timpurie. Etapa de expansiune a tratamentului este, de obicei, scurtă; ulterior, aparatul rămâne în gură o perioadă pentru a menține lățimea obținută. Dacă ați observat respirație orală sau sforăit, aș dori să notez și acest aspect.”

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„Aparatul de expansiune se fixează pe palat și trebuie activat prin rotire, conform instrucțiunilor. La primele activări, poate apărea o senzație de presiune în zona nasului și a palatului. Poate apărea un spațiu temporar între dinții frontali; este un fenomen așteptat, care se va închide ulterior.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Mandibula îi crește strâmb.	✓ Mandibula deviază spre o parte la închidere; vă explic cum se poate corecta.
✗ Nu doare deloc.	✓ În primele zile poate apărea o senzație de presiune; aceasta durează de obicei puțin.
✗ Spațiul care apare între dinți este o problemă.	✓ Apariția unui spațiu temporar între dinții frontali este un fenomen așteptat.

Maxilar îngust, adult

Cui: Pacient (adult) **Mesaj principal: Dacă sutura este osificată, opțiunile sunt diferite**

Cadru clinic (pentru medic): Ocluzie inversă laterală bilaterală la adult, maxilar îngust. De evaluat: limitele expansiunii dentare, expansiunea asistată de mini-implanturi (MARPE) sau expansiunea chirurgicală.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Maxilarul superior este îngust în raport cu cel inferior, motiv pentru care dinții posteriori se închid invers pe ambele părți. La copii, expansiunea este mai ușoară, deoarece sutura mediană a maxilarului nu este încă osificată. La vârsta adultă, această sutură este în mare parte osificată, prin urmare opțiunile sunt diferite. În cazul unei îngustări ușoare, putem obține o lățime limitată prin înclinarea controlată a dinților spre exterior, însă acest lucru are limite în ceea ce privește susținerea gingivală și osoasă. În cazul unei îngustări pronunțate, se poate lua în considerare expansiunea pe suport osos sau expansiunea asistată chirurgical. Astăzi vă voi explica ce cale este realistă în situația dumneavoastră și ce presupune fiecare. Vom monitoriza îndeaproape sănătatea gingiilor pe tot parcursul procesului.”

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„În cazul expansiunii pe suport osos, aparatul se sprijină pe mici șuruburi inserate în palat, pe lângă dinți. În cazul expansiunii asistate chirurgical, efectuăm o mică intervenție chirurgicală înainte de expansiune. Vom evalua aceste opțiuni împreună cu medicul specialist implicat.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Îl lărgim cu aparatul dentar și rezolvăm.	✓ La vârsta adultă, expansiunea are limite; haideți să discutăm deschis despre opțiuni.
✗ Dacă ați fi venit când erați copil...	✓ Haideți să stabilim împreună calea cea mai potrivită pentru situația dumneavoastră actuală.
✗ Gingia dumneavoastră nu va avea de suferit.	✓ Vom monitoriza îndeaproape sănătatea gingiilor pe parcursul tratamentului.

Ocluzie inversă frontală pe un singur dinte

Cui: Pacient sau părinte

Mesaj principal: Dinte blocat; rezolvare timpurie pentru sănătatea dintelui și a gingiei

Cadru clinic (pentru medic): Un singur incisiv superior se închide în spatele celui inferior; posibilă recesiune gingivală sau uzură dentară. Relația osoasă este de obicei normală. Corecție prin mecanică simplă.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Unul dintre dinții frontali superiori rămâne în spatele dintelui inferior în momentul închiderii gurii. Deoarece ceilalți dinți sunt într-o relație normală, considerăm că problema nu provine din structura maxilarelor, ci din poziția acelui dinte. Dacă această situație persistă, poate duce la retracția gingiei la dintele inferior sau la uzura ambilor dinți. De aceea, vă recomand să nu amânați corecția. Astfel de probleme izolate la un singur dinte pot fi corectate, de cele mai multe ori, printr-un tratament limitat; trebuie însă să verificăm dacă există suficient spațiu pentru a aduce dintele în poziția corectă. Dacă nu există suficient spațiu, trebuie mai întâi să creăm spațiu. După tratament, vom planifica o contenție pentru ca dintele să nu revină în poziția anterioară.”

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„Pentru a aduce dintele în față, putem folosi un aparat mic sau un tratament fix limitat. Pentru ca dintele să se poată mișca fără blocaje, putem aplica înălțătoare de ocluzie pe dinții posteriori.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Un dinte stă invers, nu contează.	✓ Acest dinte poate afecta în timp gingia și smalțul; recomand o corecție timpurie.
✗ Îl rezolvăm în două săptămâni.	✓ Durata depinde de spațiul disponibil; vom stabili detaliile la controale.
✗ Nu e nevoie de contenție.	✓ Vom planifica o contenție pentru ca dintele să nu revină în poziția anterioară.

Ocluzie în foarfecă

Cui: Pacient **Mesaj principal: Dinți posteriori deviați spre exterior; plan detaliat**

Cadru clinic (pentru medic): Dintele/dinții posteriori superiori sunt poziționați vestibular față de dinții inferiori, fără contact; un dinte sau un segment. De evaluat: înclinarea axului dentar, extruzia și necesarul de ancoraj; posibilitatea mecanicii cu mini-implanturi.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Unii dintre dinții dumneavoastră posteriori nu se întâlnesc cu dintele opus în momentul închiderii, ci trec pe lângă partea exterioară a acestuia. În acest caz, acești dinți nu participă complet la masticație și, în timp, pot erupe mai mult decât este necesar. Scopul tratamentului este de a aduce acești dinți într-o relație corectă cu dinții opuși. Pentru aceasta, dintele trebuie înclinat spre interior, intrudat ușor dacă este necesar, iar dintele opus trebuie și el adus într-o poziție adecvată. În anumite cazuri, pentru a efectua aceste mișcări fără efecte secundare nedorite, folosim dispozitive temporare, cum ar fi mini-implanturile sau elasticele încrucișate. Dacă problema este limitată la un singur dinte, tratamentul poate fi mai scurt; dacă sunt implicați mai mulți dinți, planul va fi mai complex. Vă voi arăta acest lucru pe radiografii.”

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„Elasticele încrucișate sunt gume pe care le agățați între butoni mici lipiți pe dinții superiori și inferiori. Le veți schimba dumneavoastră în fiecare zi. În primele zile, poate apărea o sensibilitate în timpul masticației.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Acești dinți stau complet greșit.	✓ Acești dinți nu intră în contact complet cu dinții opuși; vă voi explica cum pot fi corectați.
✗ E suficient să puneți elasticele din când în când.	✓ Purtarea regulată a elasticelor este necesară pentru ca mișcarea să aibă loc.
✗ Se rezolvă foarte repede.	✓ Durata depinde de numărul dinților implicați; haideți să analizăm împreună radiografiile.

MODULUL 06

Numărul și poziția dinților

Dinți incluși, absenți, supranumerari și anchilozanți; pierderea spațiului.

În acest capitol sunt incluse cazurile 29–34. Caută cazul în tabel și deschide pagina corespunzătoare.

NR.	TIPUL CAZULUI	CĂTRE CINE	MESAJ PRINCIPAL
29	Canin superior inclus	Pacient sau părinte	Expunerea chirurgicală și tracțiunea ortodontică
30	Agenesie de incisiv lateral superior	Pacient sau părinte	Deschiderea spațiului sau închiderea breșei?
31	Pierderea precoce a dinților temporari, menținătorul de spațiu	Părinte	Spațiul pierdut este greu de recuperat
32	Dinte lipsă la adult, ortodonție pre-implantară	Pacient (adult)	Pregătirea spațiului este o sarcină multidisciplinară
33	Dinte supranumerar (meziodens) sau incisiv neerupt	Părinte	Fără îndepărtarea obstacolului, dintele nu va erupe
34	Dinte temporar cu suspiciune de anchiloză	Părinte	Dintele poate fi sudat de os; monitorizare și temporizare

Canin superior inclus

Către cine: Pacient sau părinte **Mesaj principal: Expunerea chirurgicală și tracțiunea ortodontică**

Cadru clinic (pentru medic): Caninul superior este inclus sau are un traseu de erupție deviat; poziția sa a fost determinată prin imagistică 3D. Opțiuni: extracția caninului temporar și monitorizare, expunere chirurgicală + tracțiune ortodontică, rar extracția.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Caninul superior nu a putut erupe singur și a rămas în os. Am examinat pe radiografii unde este poziționat dintele și cât de aproape se află de rădăcinile dinților vecini. În cele mai multe cazuri, acest dinte poate fi adus pe arcadă, însă pentru aceasta, chirurgul oro-maxilo-facial trebuie să descopere zona de deasupra dintelui și să aplice un mic buton pe acesta. Ulterior, vom trage dintele în poziția corectă, lent și controlat, cu ajutorul aparatului. Acest proces poate dura mai mult decât alinierea celorlalți dinți. În funcție de poziția dintelui, pot exista și alte opțiuni; uneori este suficient să extragem dintele temporar și să monitorizăm situația o perioadă. Pe baza investigațiilor, îți voi arăta care este calea potrivită.”

DACĂ ESTE NECESARĂ EXTRACȚIA SAU APARATUL, CUM EXPLICĂM

„Expunerea chirurgicală este efectuată de chirurgul oro-maxilo-facial sub anestezie. Ulterior, poate exista o ușoară sensibilitate timp de câteva zile. Cu ajutorul butonului aplicat pe dinte, îl vom ghida lent către poziția sa. Până când dintele ajunge pe arcadă, controalele periodice sunt esențiale.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	SPUNE ÎN SCHIMB
✗ Vom aduce cu siguranță acest dinte pe arcadă.	✓ În majoritatea cazurilor este posibil; îți voi explica opțiunile în funcție de poziția dintelui tău.
✗ Rădăcina dintelui vecin s-a resorbit.	✓ Am evaluat pe radiografii relația cu dintele vecin; haideți să vedem împreună ce am observat.
✗ Este doar o mică incizie, nu e nimic.	✓ Expunerea chirurgicală este o intervenție; chirurgul vă va informa detaliat.

Agenesie de incisiv lateral superior

Către cine: Pacient sau părinte **Mesaj principal: Deschiderea spațiului sau închiderea breșei?**

Cadru clinic (pentru medic): Agenezia unuia sau a ambilor incisivi laterali superiori. Opțiuni: închiderea breșei și remodelarea caninului sub formă de incisiv lateral, sau menținerea spațiului și soluție protetică/implantară ulterioară.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Pe radiografii observăm că unul dintre incisivii laterali nu s-a format deloc. În astfel de situații, există două căi principale. Prima este închiderea breșei: vom ghida caninul în spațiul respectiv și îi vom modifica forma cu material compozit sau mici corecții, pentru a semăna cu un incisiv lateral. A doua cale este menținerea spațiului la o lățime adecvată și planificarea ulterioară a unei protezări în acel loc. În cazul celei de-a doua opțiuni, soluția definitivă se realizează de obicei după finalizarea creșterii; până atunci, folosim o soluție temporară. Alegerea căii potrivite depinde de ocluzie, de forma și culoarea caninului, de linia zâmbetului și de dorința dumneavoastră. În ambele cazuri, vom colabora cu medicul dumneavoastră dentist sau cu medicul protetician."

DACĂ ESTE NECESARĂ EXTRACȚIA SAU APARATUL, CUM EXPLICĂM

„În cazul soluției de menținere a spațiului, vom păstra breșa la o lățime adecvată pentru dintele ce va fi inserat ulterior. În această perioadă, din motive estetice, se poate utiliza un dinte temporar. Momentul soluției definitive va fi stabilit după finalizarea creșterii."

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	SPUNE ÎN SCHIMB
✗ Vom insera un implant, e simplu.	✓ Ulterior se poate realiza o protezare în acest loc; haideți să planificăm împreună momentul și condițiile necesare.
✗ Dacă închidem spațiul, nimeni nu va observa.	✓ Forma și culoarea caninului influențează rezultatul; haideți să discutăm avantajele și dezavantajele.
✗ Nu contează ce cale alegem.	✓ Există diferențe între cele două căi din punctul de vedere al îngrijirii, duratei și esteticii.

Pierderea precoce a dinților temporari, menținător de spațiu

Cui: Părinte **Mesaj principal: Spațiul pierdut este greu de recuperat**

Cadru clinic (pentru medic): Pierderea precoce a unui molar temporar (carie sau extracție); mai este timp până la erupția dintelui permanent. Se ia în considerare menținerea spațiului cu un menținător.

CE SĂ ÎI SPUNEM PĂRINTELUI

„Unul dintre molarii temporari ai copilului dumneavoastră a fost pierdut înainte ca dintele permanent de dedesubt să erupă. Rolul acestui dinte era de a menține spațiul până la apariția dintelui permanent. Dacă nu păstrăm acest spațiu, dinții vecini pot migra spre locul gol, îngustând spațiul necesar dintelui permanent. Acest lucru poate duce ulterior la înghesuire sau la retenția dintelui. Pentru a preveni acest lucru, vă recomand un dispozitiv simplu, numit menținător de spațiu. Acest aparat va păstra spațiul până la erupția dintelui permanent, iar noi vom monitoriza situația la controale. Când dintele permanent începe să erupă, vom îndepărta aparatul. În această perioadă, protecția celorlalți dinți temporari împotriva cariilor este cel puțin la fel de importantă ca aparatul în sine.”

DACĂ ESTE NECESARĂ EXTRACȚIA SAU APARATUL, CUM EXPLICĂM

„Menținătorul de spațiu este un dispozitiv mic care se fixează pe dintele vecin sau se sprijină pe palat. Majoritatea copiilor se obișnuiesc cu el rapid în timpul masticației și al vorbirii. Dacă evită alimentele lipicioase și dure, aparatul nu se va deplasa.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Dacă se pierde acest spațiu, dintele lui nu va mai ieși niciodată.	✓ Dacă nu menținem spațiul, erupția dintelui permanent poate fi mai dificilă; de aceea recomand un menținător.
✗ Dintele temporar oricum ar fi căzut.	✓ Dintele temporar menținea spațiul pentru cel permanent; această sarcină este preluată acum de aparat.
✗ Menținătorul va rămâne acolo toată viața.	✓ Când dintele permanent începe să erupă, îl vom îndepărta.

Dinte lipsă la adult, ortodonție pre-implantară

Cui: Pacient (adult) **Mesaj principal: Pregătirea spațiului este o sarcină multidisciplinară**

Cadru clinic (pentru medic): Adult; dinții vecini s-au înclinat în locul dintelui extras, antagonistul a elongat. Redresarea dinților și alinierea spațiului înainte de tratamentul protetic/implantar.

CE SĂ ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„În locul dintelui extras în urmă cu câțiva ani, dinții vecini s-au înclinat, iar dintele de pe arcada opusă a migrat ușor în jos. Din acest motiv, este mai dificil să realizăm o lucrare protetică adecvată în acea zonă. Prin tratamentul ortodontic, putem pregăti un spațiu în care medicul protetician sau implantologul să poată lucra corect. Scopul nostru este să redresăm dinții înclinați, să ajustăm lățimea spațiului și să îmbunătățim poziția dintelui antagonist. De cele mai multe ori, acesta este un tratament limitat, care nu afectează întreaga dantură. Vom elabora planul împreună cu celălalt medic curant, astfel încât să nu existe pauze între finalizarea ortodonției și etapa protetică. De asemenea, vom monitoriza sănătatea gingivală pe tot parcursul procesului.”

DACĂ ESTE NECESARĂ EXTRACȚIA SAU APARATUL, CUM EXPLICĂM

„În acest tratament, poate fi suficient să aplicăm bracheți sau mici dispozitive doar pe zona afectată. Uneori folosim mini-implanturi pentru ancoraj, pentru a deplasa dinții în direcția dorită. La final, vom verifica împreună dacă zona este pregătită pentru colegul protetician.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ A ajuns așa pentru că ați scos acel dinte.	✓ În timp, dinții vecini s-au înclinat în spațiul liber; acest lucru poate fi corectat.
✗ După tratamentul ortodontic, sigur veți avea un implant.	✓ Scopul nostru este pregătirea zonei; decizia privind implantul aparține medicului specialist.
✗ Aveți nevoie de aparat pe toți dinții.	✓ De cele mai multe ori, un tratament limitat este suficient; haideți să facem planul împreună.

Dinte supranumerar (meziodens) sau incisiv neerupt

Cui: Părinte **Mesaj principal: Fără îndepărtarea obstacolului, dintele nu va erupe**

Cadru clinic (pentru medic): Dinte supranumerar în regiunea anterioară superioară; împiedică erupția incisivului permanent sau cauzează diastemă. Extracție chirurgicală, monitorizare, la nevoie deschiderea spațiului și tracțiune.

CE SĂ ÎI SPUNEM PĂRINTELUI

„Pe radiografii observăm că în regiunea anterioară superioară a copilului dumneavoastră există un dinte supranumerar. Acest dinte poate împiedica erupția dintelui permanent din față sau poate cauza un spațiu între dinții frontali. Dintele supranumerar este, de obicei, îndepărtat de către chirurgul oro-maxilo-facial. După extracție, vom monitoriza o perioadă dacă dintele permanent va erupe de la sine. În unele cazuri, dintele apare natural, în altele trebuie să deschidem spațiul și să îl ghidăm la locul lui prin tratament ortodontic. Vă voi înmâna în scris pașii procesului și programările pentru controale. Aș dori să îi explic și copilului dumneavoastră, pe înțelesul vârstei sale, despre ce este vorba, pentru a nu fi îngrijorat pe parcursul tratamentului.”

DACĂ ESTE NECESARĂ EXTRACȚIA SAU UN APARAT, CUM EXPLICĂM

«Extracția dintelui supranumerar este o intervenție chirurgicală scurtă, efectuată sub anestezie. Ulterior, vom monitoriza erupția dintelui permanent timp de câteva săptămâni sau luni. Dacă este necesar, în etapa următoare, vom ghida dintele spre poziția corectă printr-un tratament limitat.»

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Acest dinte este o anomalie.	✓ Dintele supranumerar este o situație frecventă; îți voi explica pas cu pas ce vom face.
✗ Dacă îl extragem, dintele va ieși imediat.	✓ După extracție, vom monitoriza o perioadă erupția dintelui permanent.
✗ Operația este un fleac, nu va fi nicio problemă.	✓ Este vorba despre o intervenție scurtă; chirurgul oro-maxilo-facial vă va oferi toate detaliile.

Dinte temporar cu suspiciune de anchiloză

Cui: Părinte | Mesaj principal: Dintele poate fi sudat de os; monitorizare și temporizare

Cadru clinic (pentru medic): Molarul temporar a rămas sub planul de ocluzie față de vecini (infraocluzie), poate prezenta un sunet mat la percuție. De urmărit: prezența dintelui permanent subiacent, ritmul progresiei și înclinarea dinților adiacenți.

CE SĂ ÎI SPUNEM PĂRINTELUI

«Unul dintre molarii temporari ai copilului pare să fi rămas mai jos față de dinții vecini. Acest lucru este, de obicei, legat de faptul că rădăcinile dintelui au fuzionat cu osul înconjurător. Un astfel de dinte nu poate crește odată cu restul dinților în timpul dezvoltării maxilarelor și, în timp, poate rămâne și mai jos. Dacă există un dinte permanent dedesubt și procesul este lent, poate fi suficient să îl monitorizăm o perioadă. Totuși, dacă dinții adiacenți încep să se încline spre el sau diferența de nivel crește, poate fi luată în calcul extracția dintelui și menținerea spațiului. Dacă nu există un dinte permanent dedesubt, planul este diferit; trebuie să discutăm acest aspect separat. Vom monitoriza acest dinte prin măsurători la controalele periodice.»

DACĂ ESTE NECESARĂ EXTRACȚIA SAU UN APARAT, CUM EXPLICĂM

«Dacă este necesară extracția, putem folosi un menținător de spațiu pentru a păstra locul. Dacă nu există un dinte permanent dedesubt, vom evalua împreună opțiuni precum păstrarea dintelui temporar pentru o perioadă sau tratarea planificată a spațiului.»

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Acest dinte este mort.	✓ Rădăcina dintelui poate fi sudată de os; vom monitoriza acest aspect la controale.
✗ Trebuie să îl extragem imediat.	✓ Vom decide în funcție de dintele permanent de dedesubt și de ritmul progresiei.
✗ Se va rezolva de la sine.	✓ Acest dinte, de regulă, nu se ridică de la sine; este necesară monitorizarea periodică.

MODULUL 07

Adulți și situații speciale

Pacient parodontal, cererea pentru aliniatoare transparente, recidivă, tratament limitat și disfuncții temporo-mandibulare (ATM).

În acest capitol se află cazurile 35–40. Caută cazul în tabel și deschide pagina corespunzătoare.

NR.	TIP DE CAZ	CUI	MESAJ PRINCIPAL
35	Pacient adult parodontal	Pacient (adult)	Sănătatea gingivală întâi, apoi forțe ușoare
36	Pacient care cere aliniatoare (caz adecvat)	Pacient	Cererea este potrivită; condițiile de cooperare, clar
37	Pacient care cere aliniatoare (caz limitat)	Pacient	Limită onestă, fără a minimaliza cererea
38	Recidivă: dinții s-au înghesuit din nou	Pacient (adult)	Despre cauză și soluție, fără a învinovăți
39	Adult care dorește doar alinierea dinților frontali	Pacient (adult)	Limitele tratamentului limitat, în scris
40	Pacient cu dureri articulare (ATM)	Pacient	Ortodonția nu este tratament pentru ATM

Pacient adult parodontal

Cui: Pacient (adult) **Mesaj principal: Sănătatea gingivală întâi, apoi forțe ușoare**

Cadru clinic (pentru medic): Adult; pierdere osoasă, migrarea sau deschiderea în evantai a dinților frontali. Mai întâi tratament parodontal și stabilizare; forțe ușoare, contenție fixă pe termen lung.

CE SĂ ÎI SPUNEM PACIENTULUI

«În trecut, a avut loc o pierdere a suportului gingival și osos, iar deplasarea dinților frontali în timp este legată în mare măsură de acest lucru. Tratamentul ortodontic poate ajuta la realinierea acestor dinți și poate facilita igienizarea lor. Totuși, regula principală aici este: cât timp boala parodontală nu este sub control, nu deplasăm dinții. Mai întâi, împreună cu parodontologul dumneavoastră, finalizăm tratamentul gingival și stabilim programul de îngrijire periodică. Pe parcursul tratamentului, vom folosi forțe mai ușoare și vom verifica starea gingiilor la intervale frecvente. Nu pot promite că ortodonția va reface osul pierdut. Pentru a menține noua poziție a dinților, este necesară, de regulă, o contenție fixă pe termen lung.»

DACĂ ESTE NECESARĂ EXTRACȚIA SAU UN APARAT, CUM EXPLICĂM

«În acest tratament pot fi utilizați bracheți sau alignere transparente; alegerea depinde de starea gingivală și de ușurința igienizării. Pe durata tratamentului, programările pentru igienizarea gingivală vor continua.»

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Cu aparatul dentar se va rezolva și gingia.	✓ Ortodonția poate facilita igienizarea; tratamentul gingival continuă separat.
✗ V-ați neglijat gingiile.	✓ Monitorizăm împreună starea gingiilor.
✗ Osul va crește la loc.	✓ Nu pot promite că vom recupera osul pierdut; scopul nostru este menținerea suportului existent.

Pacient care solicită alignere transparente (caz adecvat)

Cui: Pacient **Mesaj principal: Solicitarea este adecvată; condițiile colaborării sunt clare**

Cadru clinic (pentru medic): Pacientul dorește o metodă invizibilă; cazul poate fi planificat cu alignere transparente. Trebuie explicate timpul de purtare zilnic, atașamentele, IPR-ul și eventualele corecții intermediare.

CE SĂ ÎI SPUNEM PACIENTULUI

«Cazul dumneavoastră pare adecvat pentru a fi planificat cu tratament prin alignere transparente. În această metodă, purtați o serie de gutiere transparente ușor diferite, iar dinții se deplasează pas cu pas. Cel mai important aspect: alignerele lucrează doar atunci când sunt în gură. De aceea, cu excepția meselor și a periajului, trebuie să le purtați cea mai mare parte a zilei. Pe suprafața unor dinți putem aplica mici proeminențe de culoarea dintelui pentru ca gutierele să adere mai bine, iar dacă este necesar, putem îndepărta o cantitate minimă de smalț de pe fețele laterale ale dinților. Pe parcursul tratamentului, planul poate necesita uneori corecții intermediare; acest lucru este normal. După finalizare, purtarea contenției este obligatorie, la fel ca în cazul celorlalte metode.»

DACĂ ESTE NECESARĂ EXTRACȚIA SAU UN APARAT, CUM EXPLICĂM

«Micile proeminențe aplicate pe dinți sunt de culoarea acestora și vor fi îndepărtate prin șlefuire la finalul tratamentului. Vom exersa împreună inserarea și îndepărtarea gutierelor la prima ședință.»

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Este invizibil, nimeni nu va observa.	✓ Alignerele transparente sunt aproape insesizabile; se pot vedea dacă sunt privite de aproape.
✗ Purtați-le când aveți chef.	✓ Gutierele lucrează doar când sunt purtate; trebuie să stea în gură cea mai mare parte a zilei.
✗ Cu alignerele terminați mai repede.	✓ Durata depinde de caz; depinde mai mult de colaborare decât de metodă.

Pacient care solicită alignere transparente (caz limitat)

Cui: Pacient **Mesaj principal: Limită onestă fără a minimaliza solicitarea**

Cadru clinic (pentru medic): Pacientul dorește alignere transparente; cazul este complex (discrepanță osoasă marcată, dinte inclus, rotații severe etc.). Plan hibrid, tratament fix sau gestionarea așteptărilor.

CE SĂ ÎI SPUNEM PACIENTULUI

«Înțeleg foarte bine că doriți alignere transparente; au avantaje importante din punct de vedere estetic și al confortului. În cazul dumneavoastră însă, câteva mișcări, cum ar fi corecția dinților sever rotiți sau modificarea relației dintre maxilare, se numără printre cele care sunt greu de realizat predictibil cu alignere transparente. Acest lucru nu înseamnă că metoda este greșită; doar că, în cazul dumneavoastră, are limitări. Aș dori să vă ofer trei opțiuni: tratamentul complet cu bracheți fixați; începem partea dificilă cu tratament fix, apoi continuăm cu alignere transparente; sau ne propunem doar o îmbunătățire limitată cu alignere. Vă voi spune deschis ce oferă și ce nu fiecare variantă. Decizia vă aparține; datoria mea este să vă prezint onest opțiunile.»

DACĂ ESTE NECESARĂ EXTRACȚIA SAU UN APARAT, CUM EXPLICĂM

«Bracheții ceramici sau cei de culoarea dintelui sunt variantele mai puțin vizibile ale tratamentului fix. În planul hibrid, efectuăm mai întâi mișcările dificile cu tratament fix, apoi trecem la alignerele transparente.»

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Alignerele nu sunt bune pentru dumneavoastră.	✓ Unele mișcări sunt dificile cu alignerele; haideți să evaluăm împreună opțiunile.
✗ Facem cu gutiere și vedem noi.	✓ Haideți să discutăm onest de la început ce putem obține cu gutierele.
✗ Aparatul fix este oricum mai bun.	✓ Fiecare metodă are cazurile sale potrivite; discutăm despre cazul dumneavoastră.

Recidivă: dinții s-au înghesuit din nou

Cui: Pacient (adult) **Mesaj principal: Despre cauză și soluție, fără a învinovăți**

Cadru clinic (pentru medic): Pacient care a mai urmat un tratament ortodontic; a întrerupt contenția sau retainerul s-a rupt, dinții s-au deplasat. Retratament limitat și contenție pe termen lung.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Este un fenomen frecvent ca dinții să înceapă să se deplaseze după tratamentul efectuat în urmă cu câțiva ani. Dinții pot efectua mici mișcări pe tot parcursul vieții; dacă purtarea aparatului de contenție este întreruptă sau acesta se rupe, aceste mișcări pot deveni mai pronunțate. Acest lucru nu este neapărat vina dumneavoastră sau a medicului anterior. În cadrul consultației, am evaluat gradul actual al deplasării și modul în care aceasta afectează ocluzia. În majoritatea cazurilor de recidivă, poate fi suficient un tratament mai scurt, limitat, care să nu implice întreaga dantură. De această dată, însă, haideți să discutăm planul de contenție încă de la început și să acceptăm faptul că acesta va fi pe termen lung. Dacă deplasarea afectează și ocluzia, vom extinde planul în mod corespunzător."

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„De această dată, după tratament, vă putem recomanda utilizarea combinată a unui fir de contenție lingual fix și a unei gutiere de contenție transparente purtate pe timpul nopții. Îngrijirea și verificarea contenției fac parte din tratament."

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Tratamentul anterior a fost făcut greșit.	✓ Dinții se pot deplasa în timp; să ne concentrăm pe ceea ce putem face acum.
✗ Dacă nu ați fi întrerupt contenția...	✓ De această dată, să stabilim împreună planul de contenție încă de la început.
✗ Acum va fi cu siguranță definitiv.	✓ Prin contenția pe termen lung, încercăm să menținem rezultatul.

Adult care solicită doar alinierea dinților frontali

Cui: Pacient (adult) **Mesaj principal: Limitele tratamentului limitat trebuie să fie în scris**

Cadru clinic (pentru medic): Adult; solicită doar alinierea dinților frontali vizibili în zâmbet. Ocluzia posterioară este acceptabilă sau pacientul nu dorește un tratament comprehensiv. Obiectivele tratamentului limitat trebuie clar stabilite.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Înțeleg că vă deranjează în principal dinții frontali, vizibili atunci când zâmbiți. În cazul dumneavoastră, ar putea fi posibil un tratament limitat, concentrat doar pe dinții frontali. Acesta are avantaje: de obicei este mai scurt și necesită mai puține aparate. Totuși, trebuie să cunoașteți și limitele tratamentului limitat. Nu vom modifica ocluzia dinților posteriori și nici relația dintre oasele maxilare, astfel încât anumite probleme vor rămâne neschimbate. Iar dacă pentru alinierea dinților frontali este nevoie de spațiu, îl putem obține prin stripping (IPR) măsurat pe suprafețele laterale ale dinților. Haideți să stabilim împreună, în scris, ce vizează tratamentul și ce nu; astfel, la final, amândoi vom avea aceleași așteptări.”

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„În cazul tratamentului limitat, pe dinții frontali se pot aplica bracketi sau gutiere transparente. În anumite cazuri, obținem puțin spațiu prin IPR. Chiar și tratamentul limitat necesită contenție.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Ne uităm la cei din față, cei din spate nu contează.	✓ Nu vom modifica ocluzia posterioară; vă explic ce înseamnă acest lucru.
✗ Tratamentul limitat rezolvă totul.	✓ Să consemnăm în scris obiectivele și limitele noastre.
✗ Dacă nu acceptați tratamentul complet, veți regreta.	✓ Vă explic ce ar adăuga tratamentul comprehensiv; alegerea vă aparține.

Pacient cu simptome la nivelul articulației temporo-mandibulare (ATM)

Cui: Pacient **Mesaj principal: Ortodonția nu este un tratament pentru ATM**

Cadru clinic (pentru medic): Pacientul raportează dureri articulare, zgomote articulare sau deschidere limitată a gurii. Evaluarea ATM înainte de tratamentul ortodontic, trimiterea la medicul specialist corespunzător dacă este necesar; gestionarea așteptărilor.

CE ÎI SPUNEM PACIENTULUI

„Ați menționat că simțiți durere, zgomote articulare sau dificultăți la deschiderea gurii în articulația temporo-mandibulară; iau acest aspect în serios. Aș dori să precizez clar că tratamentul ortodontic, în sine, nu este o metodă de tratare a problemelor articulației temporo-mandibulare. Prin urmare, mai întâi aș dori să evaluez separat suferința articulară și, dacă este necesar, să solicit opinia unui medic specialist care lucrează în acest domeniu. Dacă simptomele dumneavoastră sunt sub control, putem planifica tratamentul ortodontic pentru alinierea dinților și ocluzie. Dacă în timpul tratamentului observați vreo schimbare în simptomele articulare, vă rog să îmi spuneți imediat; putem întrerupe sau modifica planul. Vom documenta starea inițială și o vom compara la fiecare control.”

CUM EXPLICĂM DACĂ ESTE NEVOIE DE EXTRACȚIE SAU APARAT

„Pe parcursul tratamentului, la fiecare control vă voi întreba despre simptomele articulare și le voi nota. Dacă este necesar, vom reduce forțele sau vom întrerupe tratamentul. Dacă este nevoie de o gutieră de noapte, o vom planifica împreună cu medicul specialist corespunzător.”

EXPRESII DE EVITAT

NU SPUNE	ÎN SCHIMB
✗ Cu aparatul dentar va trece durerea de mandibulă.	✓ Ortodonția nu este tratamentul problemelor articulare; evaluăm articulația separat.
✗ Aveți o ocluzie incorectă, de aceea vă doare.	✓ Durerea poate avea mai multe cauze; trebuie să evaluăm acest lucru separat.
✗ Nu este ceva serios.	✓ Voi documenta simptomele și le voi monitoriza la fiecare control.

MODULUL 8

Checklist după informare

Înainte ca pacientul sau părintele să părăsească cabinetul, parcurge această listă.

După informare

- [ ] Am corelat principala nemulțumire și așteptările pacientului cu planul de tratament.
- [ ] Am explicat rezultatele investigațiilor într-un mod descriptiv, fără a folosi termeni tehnici.
- [ ] Am prezentat planul propus și raționamentul din spatele acestuia.
- [ ] Am prezentat celelalte opțiuni, inclusiv monitorizarea sau refuzul tratamentului.
- [ ] Dacă sunt necesare extracții, mini-implanturi, aparate sau intervenții chirurgicale, le-am explicat separat și pe un ton calm.
- [ ] Am oferit durata tratamentului sub formă de interval estimativ; nu am oferit o dată fixă.
- [ ] Am enumerat pe rând responsabilitățile pacientului (igienă, elastice, aparat, control, contenție).
- [ ] Am rugat pacientul să rezume cu propriile cuvinte ceea ce i-am explicat.
- [ ] Am înmânat planul de tratament scris pe o singură pagină.
- [ ] Am menționat consimțământul informat utilizat în cabinetul nostru și am precizat că îi ofer timp de gândire.
- [ ] Am clarificat care este pasul următor (documentație, consultație, control sau programarea pentru începerea tratamentului).

SEMNAL DIN PARTEA PACIENTULUI	CE SĂ FACI
Tace, nu pune întrebări	Adresează întrebări deschise: „Care parte vă îngrijorează cel mai mult?"
Întreabă imediat de preț	Rezumă mai întâi ce conține planul; informează despre costuri conform procedurii obișnuite a cabinetului tău.

SEMNAL DIN PARTEA PACIENTULUI	CE SĂ FACI
Spune: „Mă mai gândesc”	Este un răspuns sănătos. Înmânează planul scris și propune o dată pentru pasul următor.
Părinții au opinii diferite	Rezumă separat îngrijorările ambelor părți; pornește de la punctul comun (Bonusul 3).
Citează recomandarea altui medic	Compară obiectivele celor două planuri fără a emite comentarii (Bonusul 2, întrebarea relevantă).

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului sau opinia de specialitate.

Pasul următor

Dacă dorești să înmânezi planul în scris pacientului, deschide fișierul **Bonus 1 · Planul de tratament pe o pagină: șabloane explicative**. Pentru pregătirea în fața întrebărilor dificile ale pacienților: **Bonus 2 · Cele mai frecvente 30 de întrebări dificile ale pacienților și răspunsurile**. Pentru structurarea planului în sine, consultă **Modulul 3 · Planificarea Clinică: de la Lista de Probleme la Mecanică** din Manualul Ortodontului.